



FUNDACJA MEDICULUS

Opieka i wiele więcej.

MAKIETA UX / UI · WIDOK PACJENTA

Aplikacja mobilna — moduł dietetyczno-psychodietetyczny

Dzienniczek żywieniowy, który nie liczy jedzenia — opisuje je i to, co dzieje się wokół niego. Dokument pokazuje przepływ ekranów pacjenta, zawartość pól i ton komunikacji. Moduł jest projektowany jako druga część tej samej aplikacji, obok modułu psychoterapeutycznego.

Widok pacjenta

Ekran 390 × 844 px · iOS / Android

15 stron · wersja robocza

SPIS TREŚCI

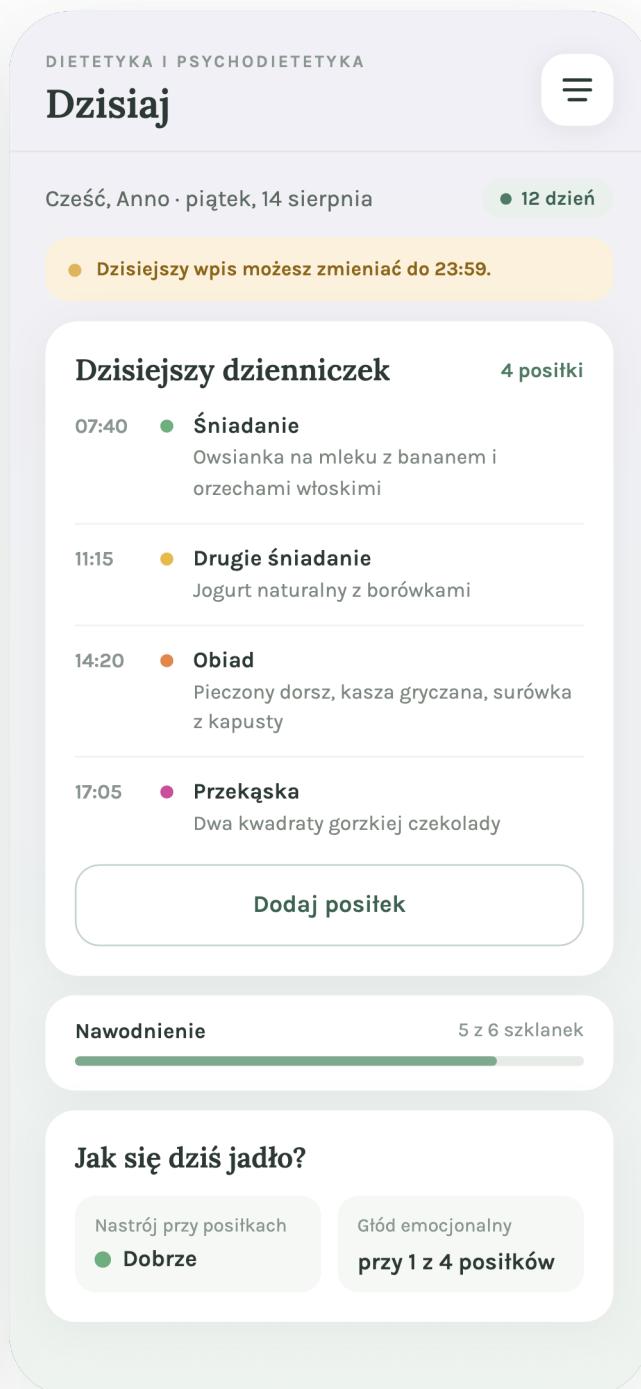
01	Strona tytułowa i spis treści	
02	Strona główna modułu — dwa stany dnia	
03	Menu i przęłaczanie modułów	
04	Dodawanie posiłku — co zjadłam	
05	Kontekst psychodietetyczny posiłku	
06	Podsumowanie dnia	
07	Historia dzienniczków żywieniowych	
08	Nawodnienie i suplementy	Etap 2
09	Aktywność fizyczna i sen	Etap 2
10	Raporty — historia i szczegół	
11	Analiza	Etap 2
12	Techniki psychodietetyczne	Etap 2
13	Profil zdrowotny	
14	Materiały edukacyjne	Etap 2
15	System wizualny	

ZAKRES DOKUMENTU

Moduł nie liczy kalorii ani makroskładników, nie zawiera bazy produktów, skanowania kodów, synchronizacji z urządzeniami ani gamifikacji. Nawigacja odbywa się wyłącznie przez menu w prawym górnym rogu — w tym module nie ma dolnego paska zakładek. Strony oznaczone pigułką „Etap 2” opisują funkcje o niższym priorytecie.



Stan pusty — dzień bez wpisów. Jedno wyraźne działanie i nic ponadto.



Stan z wpisami — oś posiłków, nawodnienie i jedno spojrzenie wstecz.

EKRAN STARTOWY

Jeden ekran, jedno zadanie

Strona główna nie podsumowuje, nie ocenia i nie pokazuje żadnej liczby, którą można potraktować jak wynik. Prowadzi do jednej rzeczy — dodania posiłku.

Licznik dni z rzędu

Przeniesiony z modułu psychoterapeutycznego. Liczy dni z wpisem, nie „sukcesy”. Przerwa go nie komentuje.

Bez dolnego paska

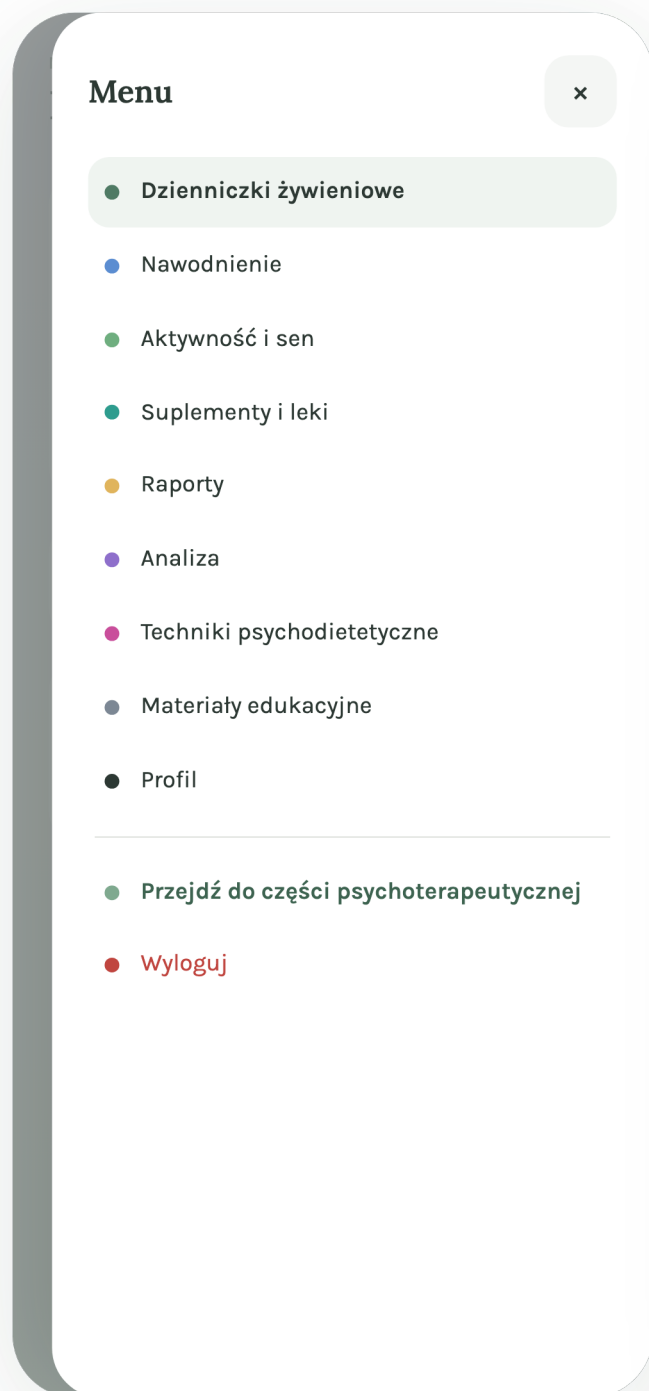
Ekran kończy się treścią. Cała nawigacja jest pod przyciskiem menu w prawym górnym rogu.

Zastrzeżenie widoczne

Informacja o braku diagnozy stoi w treści ekranu, nie w stopce ani w regulaminie.

UWAGA PROJEKTOWA

Pasek nawodnienia jest celowo najcichszym elementem ekranu — bez procentów, bez celu dziennego wyrażonego liczbą mililitrów. Kafel „Jak się dziś jadło?” pokazuje wyłącznie to, co pacjentka sama wpisała; nigdy nie dopowiada wniosku.



Menu otwarte nad przyciemnionym ekranem. Kropki są tym samym kolorem, co w całym module.



Wybór modułu – ekran przeniesiony z pierwszego dokumentu, z zaznaczoną częścią dietetyczną.

NAWIGACJA

Wszystko pod jednym przyciskiem

Menu jest jedynym punktem nawigacji w module. Otwiera się z prawej strony, przyciemnia ekran pod spodem i zamyka się gestem albo krzyżykiem.

Kolejność pozycji

Od codziennych do rzadkich. Dwie ostatnie pozycje – przejście do drugiego modułu i wylogowanie – oddzielone linią.

Jedna aplikacja

Ekran wyboru modułu jest wspólny. Dominanta pozostaje szafłowiowa, ochra oznacza wyłącznie część dietetyczną.

Pola dotykowe

Każda pozycja menu ma co najmniej 44 px wysokości aktywnej.

UWAGA PROJEKTOWA

Rezygnacja z dolnego paska oznacza, że po każdym zapisie trzeba wyraźnie pokazać drogę powrotną. Na wszystkich ekranach poza stroną główną w lewym górnym rogu jest strzałka wstecz, a po zapisaniu wpisu aplikacja wraca do strony głównej sama.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←
Nowy posiłek
≡

Co to za posiłek?

Śniadanie
Drugie śniadanie
Obiad
Podwieczorek
Kolacja
Przekąska

Godzina posiłku

Możesz zmienić, jeśli wpisujesz później

14:20

Zdjęcie talerza

najprościej

Jedno zdjęcie wystarczy. Nie musisz nic opisywać.

zdjęcie talerza

Zrób zdjęcie

Z galerii

albo opisz posiłek słowami

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←
Obiad · 14:20
≡

Zdjęcie dodane
14 sierpnia, 14:21
Zmień

Opis posiłku

Pieczony dorsz, kasza gryczana i surówka z białej kapusty.

Ilość / porcja

opcjonalnie

średni talerz, jedna dokładka kaszy

Zwyczajny tekst — wpisz tak, jak mówisz.

Miejsce

opcjonalnie

Dom
Praca
Na mieście
W drodze

Okoliczności

opcjonalnie

Sama
Z rodziną
Ze znajomymi
Przy pracy
Przed telewizorem

Zapisz posiłek

Krok 1 — kategoria, godzina i zdjęcie. Zdjęcie jest domyślną ścieżką.

Krok 2 — opis, porcja i kontekst. Wszystko poza kategorią jest opcjonalne.

KROK 1 Z 2

Zdjęcie albo słowa — dwie równorzędne drogi

Pacjentka może zapisać posiłek samym zdjęciem, samym opisem albo obiema rzeczami. Nic więcej nie jest wymagane, żeby wpis się zapisał.

Ilość jako tekst

Jedna linia, bez jednostek do wyboru i bez żadnych przeliczeń. „Pół miski”, „dwie kromki” są poprawnymi odpowiedziami.

Bez bazy produktów

Nie ma wyszukiwarki, skanera kodów ani podpowiedzi z bazy. Ekran nie pokazuje żadnej wartości odżywczej.

Godzina domyślna

Podpowiadana z zegara, edytowalna jednym dotknięciem — wpisy robione wieczorem za cały dzień muszą być łatwe.

UWAGA PROJEKTOWA

Do potwierdzenia z klientką: czy zdjęcia mają być przechowywane w aplikacji bezterminowo, czy usuwane po wygenerowaniu raportu. Ma to wpływ na zgody RODO i na to, co widzi specjalista.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Posiłek zapisany ≡

Obiad · 14:20
Pieczony dorsz, kasza gryczana i surówka z białej kapusty.

Chcesz dopisać, jak się wtedy czułaś?

To ta część, o którą pyta specjalista. Możesz ją wypełnić w całości, w kawałku albo wcale.

Rozwiń

Nie teraz

Żadne z tych pól niczego nie blokuje. Posiłek jest już zapisany.

Możesz wrócić do tego dzisiaj do 23:59 ●

Stan zwinięty – pytanie, nie formularz. „Nie teraz” jest równorzędnym wyjściem.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Jak było przy obiedzie ≡

Aktualny nastrój

Dobrze

Bardzo źle Żle Neutralnie Bardzo dobrze

Poziom stresu 4/10

Głód fizyczny 7/10

Głód emocjonalny 2/10

Emocje przy jedzeniu

Radość

Smutek

Lęk

Złość

Stres

Poczucie winy

Frustracja

Wstyd

Bezradność

Spokój

Co sprawiło, że sięgnęłaś po jedzenie?

Zwykła pora obiadu, byłam głodna po spotkaniu.

Poziom sytości po posiłku 6/10

Satysfakcja po jedzeniu Dobra

Reakcja organizmu dodaj

Własne obserwacje dodaj

Stan rozwinięty. Ekran przewija się dalej – na dole przycisk „Zapisz”, zawsze aktywny.

KROK 2 Z 2 · RDZEŃ MODUŁU

Żadne pole nie blokuje zapisu

Niepełny wpis jest lepszy niż brak wpisu. Przycisk zapisu jest aktywny od pierwszej sekundy, a pominięte pola nie są nigdzie oznaczane jako brakujące.

Kolejność pól

Nastój · stres 0–10 ·
głód fizyczny 0–10 ·
głód emocjonalny 0–10 ·
emocje · sytuacja ·
sytość · satysfakcja ·
reakcja organizmu ·
obserwacje.

Dwa głody osobno

Rozdzielenie głodu fizycznego i emocjonalnego jest jednym miejscem, z którego bierze się później analiza jedzenia emocjonalnego.

Wspólny język emocji

Te same dziesięć emocji i te same kolory co w module psychoterapeutycznym – dane z obu dzienniczków dają się zestawiać.

UWAGA PROJEKTOWA

Ekran nie komentuje wpisanych wartości – wysoki głód emocjonalny nie uruchamia żadnego komunikatu, podpowiedzi ani propozycji techniki. Interpretacja należy do specjalisty, nie do aplikacji.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←

Piątek, 14 sierpnia

≡

Oś dnia

07:40

Śniadanie

Owsianka z bananem i orzechami

●

11:15

opis

Drugie śniadanie

Jogurt naturalny z borówkami

●

14:20

Obiad

Dorsz, kasza gryczana, surówka

●

17:05

opis

Przekąska

Dwa kwadraty gorzkiej czekolady

●

Nawodnienie

5 szklanek

Sen

7 h 20 min

Aktywność

spacer 40 min

Notatka dnia

Dzień był spokojniejszy niż wczoraj. Po południu miałam ochotę na słodkie, zjadłam dwa kwadraty czekolady i to wystarczyło.

☐ Zachowanie ryzykowne

Zaznacz, jeśli chcesz to odnotować

Opis własny – opcjonalnie

Podsumowanie zbiera to, co wpisałaś. Aplikacja nie dodaje do niego żadnej oceny.

Cały dzień na jednym ekranie – bez sum, bez bilansu, bez wykresu.

WIDOK DNIA

Dzień jako relacja, nie jako wynik

Oś dnia pokazuje godzinę, zdjęcie lub opis i jedną kropkę emocji przy każdym posiłku. Nawodnienie, sen i aktywność pojawiają się tylko wtedy, gdy zostały uzupełnione – puste kafle nie są wyświetlane.

Znacznik zachowania ryzykownego

Mechanizm przeniesiony z modułu psychoterapeutycznego: pole wyboru plus opcjonalny opis własny, bez alertu, bez czerwieni, bez zmiany wyglądu ekranu po zaznaczeniu.

Do potwierdzenia

Zakres znacznika dla części dietetycznej wymaga ustalenia z klientką – czy obejmuje wyłącznie zachowania okołozyczeniowe, czy tę samą listę, co w module psychoterapeutycznym.

Miniatura zdjęcia

Posiłki zapisane zdjęciem mają miniaturę, zapisane słowami – neutralny kafelek. Obie ścieżki wyglądają na osi tak samo ważne.

Kropka emocji

Kolor pochodzi z dominującej emocji zaznaczonej przy posiłku. Brak zaznaczenia to brak kropki – nie szara kropka „nieuzupełnione”.

UWAGA PROJEKTOWA

Notatka dnia jest jednym polem tekstowym, nie zestawem pytań. Pacjentki z zaburzeniami odżywiania łatwiej piszą swobodnie niż odpowiadają na strukturę pytań o jedzenie.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←

Dzienniczki

≡

ZAPIS DO PÓŁNOCY

Dzisiejszy dzienniczek możesz zmieniać do 23:59. O północy dzień zostaje zamknięty i wpis przechodzi do archiwum – będzie widoczny, ale już bez edycji.

DZISIAJ

Piątek, 14 sierpnia

4 posiłki · nawodnienie · notatka

Edytuj

ARCHIWUM · TYLKO DO ODCZYTU

Czwartek, 13 sierpnia

5 posiłków · dominująca emocja: spokój

Zamknij

Środa, 12 sierpnia

3 posiłki · dominująca emocja: stres

Zamknij

Wtorek, 11 sierpnia

4 posiłki · dominująca emocja: radość

Zamknij

Poniedziałek, 10 sierpnia

Brak wpisu

Dzień bieżący wygląda inaczej niż archiwum – zielona ramka, przycisk „Edytuj”, żywe kolory.

ARCHIWIZACJA

Doba zamyka wpis i nie da się tego cofnąć

Ostrzeżenie o północy stoi na górze listy, w ochrze, z ramką – nie jest to szary tekst pomocniczy. Pacjentka ma je zobaczyć zanim zamknie aplikację, nie po fakcie.

Dwa różne stany wizualne

Wpis dzisiejszy: biała karta, zielona ramka, pełna kolorystyka. Wpis zarchiwizowany: karta przygaszona, pigułka „Zamknięty”, brak jakiegokolwiek przycisku edycji.

Pasek emocji dnia

Jeden segment na posiłek, w kolorze zaznaczonej emocji. Daje obraz dnia bez otwierania wpisu i bez podawania żadnej liczby.

Dni bez wpisu

Widoczne jako „Brak wpisu”, bez wykrzyknika, bez zachęty i bez przerywanej serii. Pusty dzień nie jest błędem.

Do potwierdzenia

Czy pacjentka może poprosić specjalistę o odblokowanie zamkniętego dnia, czy archiwum jest ostateczne również dla niego.

UWAGA PROJEKTOWA

Zamknięcie doby to jedyne miejsce w module z nieodwracalnym skutkiem. Dlatego komunikat pojawia się w dwóch miejscach: na liście dzienniczków i na stronie głównej przy dzisiejszym wpisie – zawsze tym samym zdaniem.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Nawodnienie

☰

Dzisiaj

cel: 6 szklanek

5 z 6 szklanek

Dodaj szybko

Szklanka
250 ml

Butelka
500 ml

Inna

Inne napoje

Herbata

Kawa

Napar ziółowy

Sok

Napój roślinny

Ostatnie 7 dni

pn wt śr cz pt sb nd

Nawodnienie – jedno dotknięcie na szklankę, bez celu wyrażonego procentem.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Suplementy i leki

☰

Przypomnienia o godzinach

✓ Witamina D3

2000 IU · raz dziennie · 08:00

od 1 marca · bezterminowo

✓ Sertralina

50 mg · raz dziennie · 08:00

od 4 stycznia · bezterminowo

lek

☐ Magnez

300 mg · raz dziennie · 21:00

od 12 czerwca do 12 września

☐ Żelazo

30 mg · co drugi dzień · 09:00

od 20 lipca do 20 października

Dodaj suplement lub lek

Lista służy pamięci i rozmowie ze specjalistą. Aplikacja nie ocenia dawek ani nie sprawdza interakcji.

Suplementy i leki na jednej liście, z odhaczaniem przyjęcia w danym dniu.

FUNKCJE WSPIERAJĄCE

Dwa proste rejestry

Oba ekrany są rejestrami, nie systemami kontroli. Wpisy zasilają raport tygodniowy tylko wtedy, gdy pacjenta faktycznie z nich korzysta.

Cel nawodnienia

Ustawiany raz, w szklankach. Niedopity dzień nie generuje komunikatu ani czerwonego stanu.

Pola pozycji

Nazwa, dawka, częstotliwość, godzina, data rozpoczęcia i zakończenia. Zakończone pozycje schodzą do archiwum listy.

Przypomnienia

Jedno powiadomienie o zadanej godzinie, bez ponawiania i bez podbijania. Można je wyłączyć jednym przełącznikiem.

UWAGA PROJEKTOWA

Leki i suplementy są na jednej liście, ale lek dostaje dyskretną etykietę – specjalista dietetyk musi wiedzieć, że pozycja pochodzi z leczenia psychiatrycznego, bez robienia z tego osobnej, wyróżnionej sekcji.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Aktywność ≡

Nowa aktywność

Rodzaj

Spacer

Rower

Basen

Joga

Siłownia

Inna

Czas trwania

40 min

Samopoczucie po

Gorzej

Bez zmian

Lepiej

Dużo lepiej

Zapisz aktywność

Kroki dzisiaj

Wpisujesz ręcznie

6 400

Dzisiaj zapisane

Spacer · 40 min

18:30 · po aktywności: lepiej

Joga · 25 min

07:00 · po aktywności: dużo lepiej

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

← Sen ≡

Ostatnia noc

Zaśniecie

23:10

Przebudzenie

06:30

Długość snu

7 h 20 min

Jakość snu

Bardzo zła

Zła

Średnia

Dobra

Bardzo dobra

Liczba przebudzeń

1

Odczucia po przebudzeniu

Wypoczęta

Zmęczona

Rozbita

Spokojna

Napięta

Ostatnie 7 nocy

pn

wt

śr

cz

pt

sb

nd

Wpis ręczny. Nie ma spalonych kalorii, tempa ani porównania z innymi dniami.

Dziennik snu – godziny, jakość, przebudzenia i odczucia po nocy.

KONTEKST DNIA

Wszystko wpisywane ręcznie

Brak synchronizacji ze smartwatchem i aplikacjami zdrowotnymi jest decyzją, nie brakiem. Dane mają być świadomym wpisem pacjentki, tak jak reszta dzienniczka.

Aktywność

Rodzaj, czas trwania i samopoczucie po. Trzy pola, jeden ekran, żadnego pomiaru intensywności.

Kroki

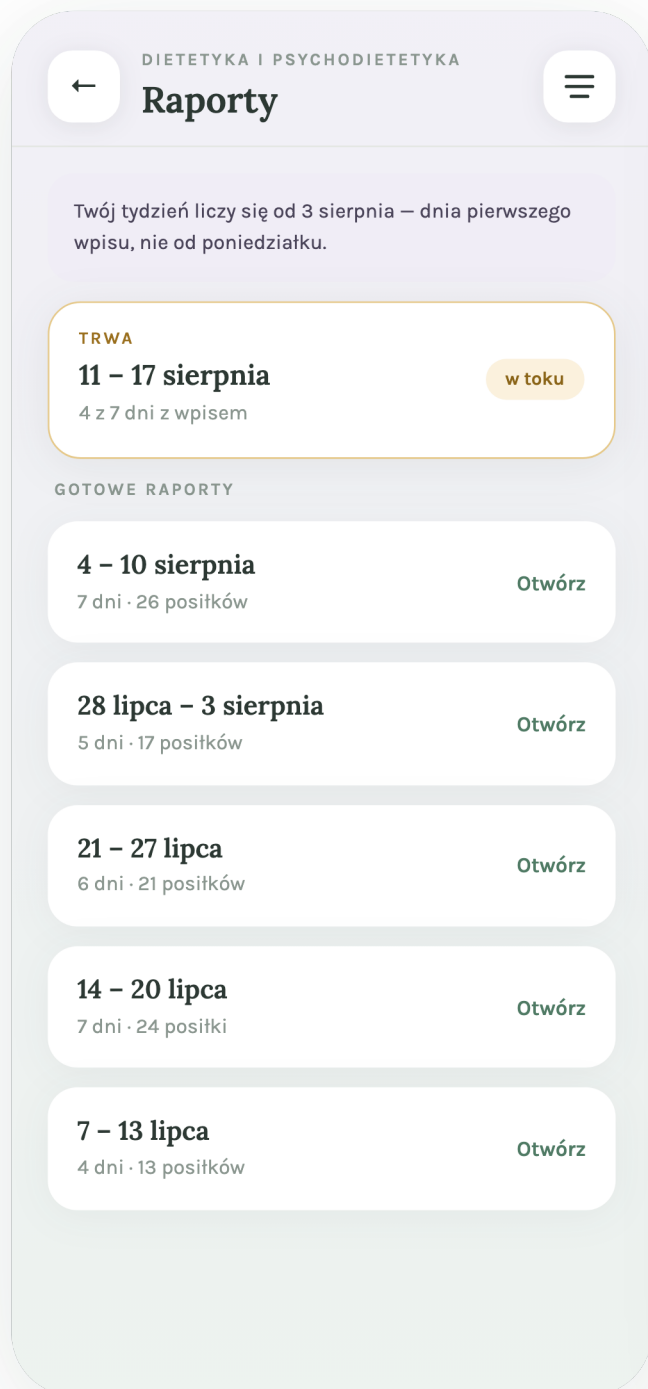
Jedno pole liczbowe przepisywane z telefonu lub krokomierza. Bez celu dziennego i bez paska postępu.

Sen a jedzenie

Dane o śnie trafiają do raportu obok wpisów o posiłkach, bez wyciągania wniosku o zależności – to zadanie specjalisty.

UWAGA PROJEKTOWA

Skala samopoczucia po aktywności zaczyna się od „Gorzej”, nie od zera. Dla części pacjentek ruch bywa obciążający i ta odpowiedź musi być równie łatwa do zaznaczenia, co pozytywna.



Historia raportów — układ ten sam, co lista dzienników.



Raport ma charakter zestawienia: data, co się działo, co zostało zastosowane.

RAPORT TYGODNIOWY

Tylko to, co pochodzi z dzienników

Raport generuje się sam, w cyklu siedmiodniowym licząc od pierwszego wpisu pacjentki. Nie zawiera ocen, interpretacji, kalorii ani rekomendacji.

Zawartość

Regularność wpisów · rozkład posiłków · emocje przy jedzeniu · głód fizyczny wobec emocjonalnego · sytuacje jedzenia emocjonalnego · nawodnienie, sen i aktywność jeśli uzupełniane · zmiany od ostatniej wizyty.

Tydzień pacjentki

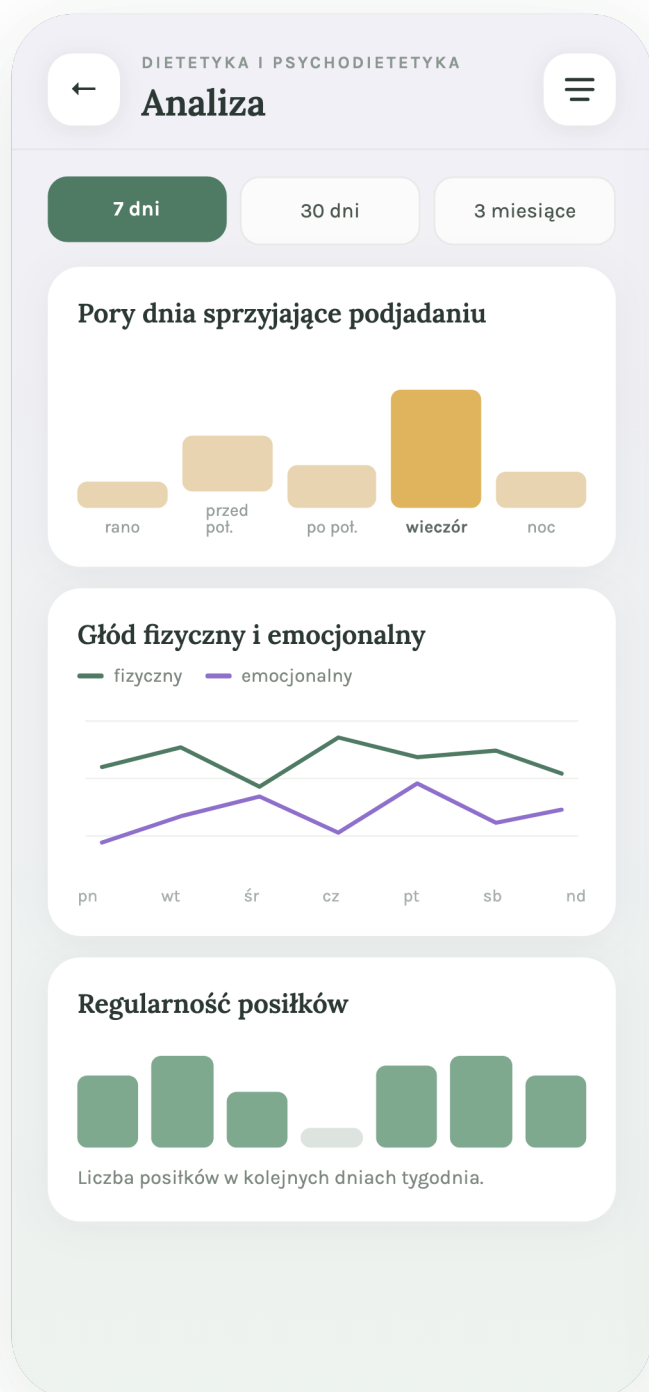
Liczony od daty pierwszego wpisu, nie od poniedziałku. Data początku tygodnia jest napisana wprost na liście.

Kwestia otwarta

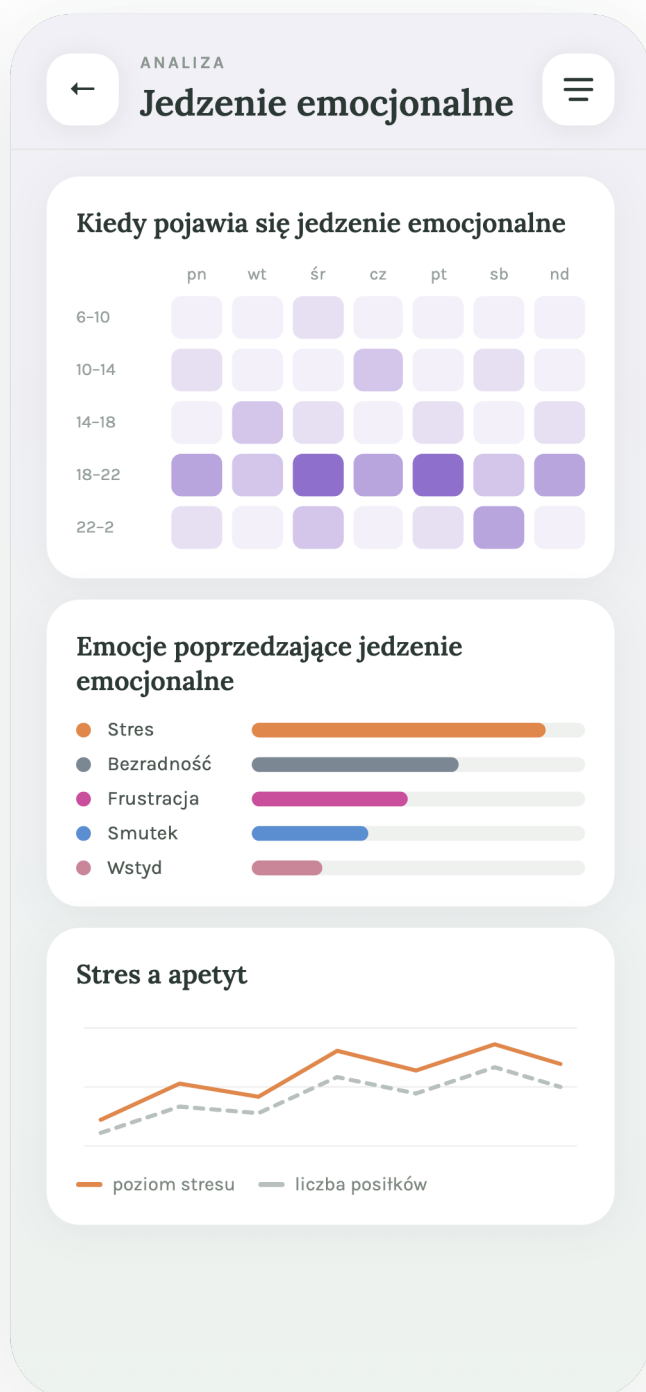
Czy raport trafia do specjalisty automatycznie, czy dopiero po potwierdzeniu przez pacjentkę. Ekran świadomie tego nie przesądza — są tu oba przyciski, ale bez informacji o adresacie.

UWAGA PROJEKTOWA

Decyzja o automatycznym wysyłaniu raportu ma konsekwencje dla zaufania: pacjentka, która wie, że wszystko idzie do specjalisty bez jej zgody, przestaje wpisywać trudne rzeczy. Rekomendujemy potwierdzenie, ale zostawiamy to do



Wykresy słupkowe i liniowe – ta sama konwencja, co w module psychoterapeutycznym.



Mapa ciepła w odcieniach lawendy – bez czerwieni i bez skali „źle / dobrze”.

WYKRESY

Obraz, nie diagnoza

Analiza pokazuje wzorce, których nie widać w pojedynczym dniu. Pod żadnym wykresem nie ma zdania wyjaśniającego, co „oznacza” wynik.

Zakres analiz

Pory podjadania · emocje poprzedzające jedzenie emocjonalne · relacja stresu i apetytu · głód fizyczny wobec emocjonalnego w czasie · regularność posiłków.

Próg danych

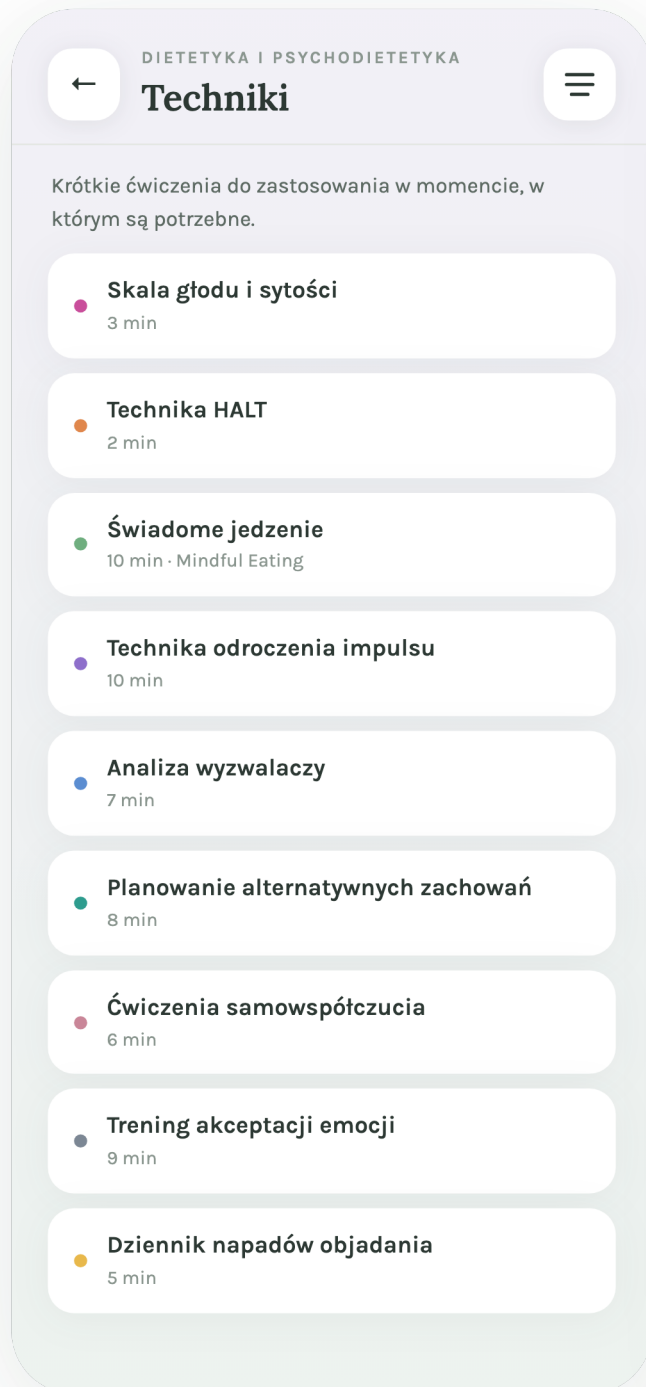
Wykres pojawia się dopiero przy komplecie danych z co najmniej pięciu dni. Wcześniej ekran pokazuje jedno zdanie, nie pusty układ współrzędnych.

Do potwierdzenia

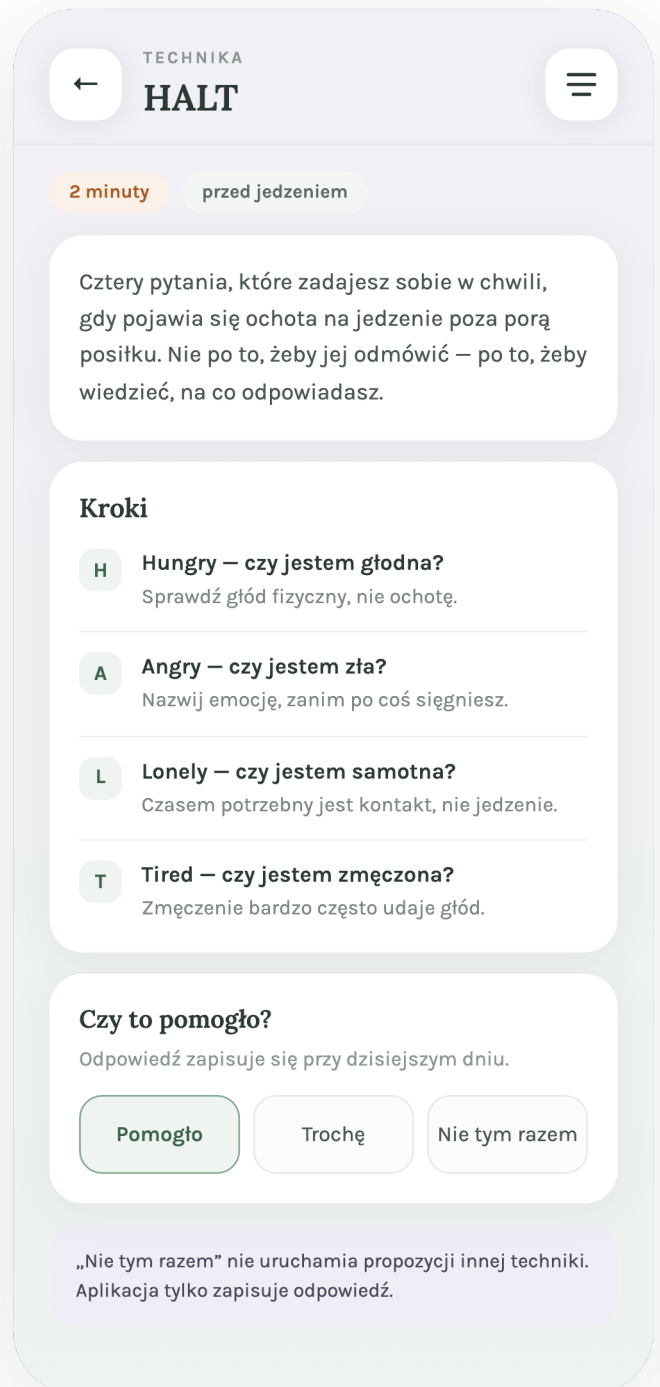
Zakres analiz dla tego modułu wymaga jeszcze potwierdzenia z klientką – zwłaszcza to, które zestawienia są klinicznie użyteczne, a które tylko ładnie wyglądają.

UWAGA PROJEKTOWA

Analiza jest jedynym miejscem w module, gdzie pacjentka widzi swoje dane zbiorczo. Dla osób z zaburzeniami odżywiania to potencjalnie trudny ekran – dlatego bez czerwieni, bez strzałek w dół i bez porównań z poprzednim okresem.



Lista bez kategorii i bez podpowiedzi „polecane dla Ciebie” — wybór należy do pacjentki.



Szczegóły techniki: opis, kroki, czas trwania i pytanie o skuteczność.

TECHNIKI

Wyłącznie tekst i prosta grafika

Bez filmów, bez nagrań audio, bez algorytmu dobierającego technikę. Dziewięć pozycji na jednej liście, w stałej kolejności.

Zastosowanie w raporcie

Zastosowana technika i odpowiedź o skuteczności trafiają do kolumny „co zostało zastosowane” w raporcie tygodniowym.

Kropka koloru

Kolor przy technice jest wyłącznie oznaczeniem porządkowym listy, nie sugestią emocji, do której technika „pasuje”.

Treść merytoryczna

Opisy i kroki przygotowuje fundacja. Zespół projektowy dostarcza strukturę ekranu i układ typograficzny.

UWAGA PROJEKTOWA

„Dziennik napadów objadania” jest na liście technik, ale jego forma wymaga osobnej rozmowy — dla części pacjentek prowadzenie takiego dziennika bywa objawem, nie narzędziem. Proponujemy udostępniać go wyłącznie po ustaleniu ze specjalistą.

DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA

←

Profil

≡

Podstawowe dane

Wiek

34

Wzrost

168 cm

Masa ciała

71 kg

Docelowa masa ciała

66 kg

Poziom aktywności fizycznej

Niski

Umiarkowany

Wysoki

Alergie i nietolerancje

Orzechy laskowe

Laktoza

+ dodaj

Preferencje żywieniowe

Wegetariańska

Wegańska

Ketogeniczna

+ własna

Przyjmowane leki i suplementy

Sertralina 50 mg

lek

Witamina D3 2000 IU

suplement

Magnez 300 mg

suplement

PROFIL

←

Zdrowie i zgody

≡

Jednostki chorobowe

Zaznacz z listy albo dopisz własną.

Insulinooporność

Hashimoto

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 2

PCOS

Niedoczynność tarczycy

Nadczynność tarczycy

Celiakia

Choroby jelit

Refluks

Nadciśnienie

Hipercholesterolemia

Zaburzenia odżywiania

Depresja

Zaburzenia lękowe

ADHD

Spektrum autyzmu

+ własna

Powiązani specjaliści

Marta Nowak

dietetyk kliniczny

Szczegóły

Piotr Zieliński

psychoterapeuta

Szczegóły

Zgody

Przetwarzanie danych o zdrowiu

Udostępnianie raportów specjalście

Masa ciała i cel wagowy jako zwykłe pola formularza – bez paska postępu i bez licznika.

Lista jednostek chorobowych z możliwością dopisania własnej, powiązani specjaliści i zgody.

PROFIL

Dane, nie cel do osiągnięcia

Masa ciała i cel wagowy to dwa pola tekstowe obok siebie. Nie ma między nimi paska postępu, licznika „zostało X kg” ani wykresu zmian w czasie.

Dlaczego bez paska

Wśród pacjentek są osoby z zaburzeniami odżywiania. Wizualizacja odległości do wagi docelowej działa u nich jak wyzwalacz, nie jak motywacja.

Lista chorób

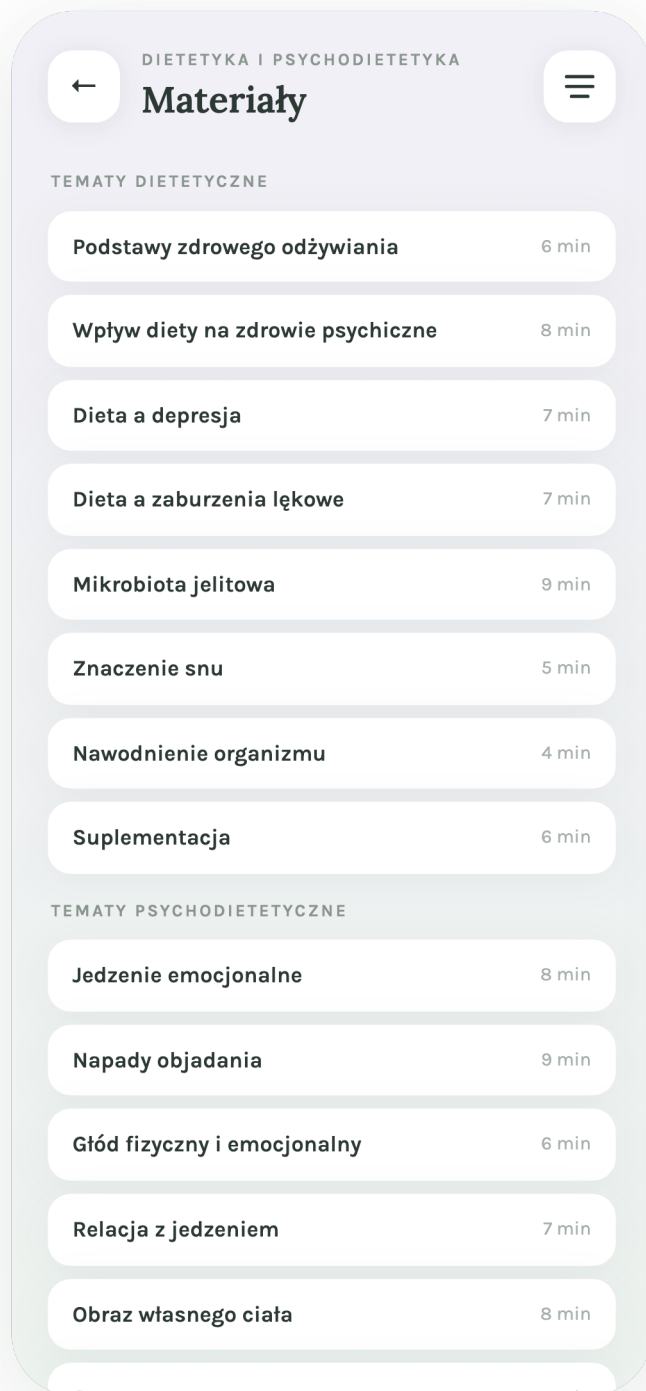
Osiemnaście pozycji z listy plus pole własne. Rozpoznania psychiatryczne stoją w tej samej liście, co somatyczne – bez osobnej sekcji.

Wspólny profil

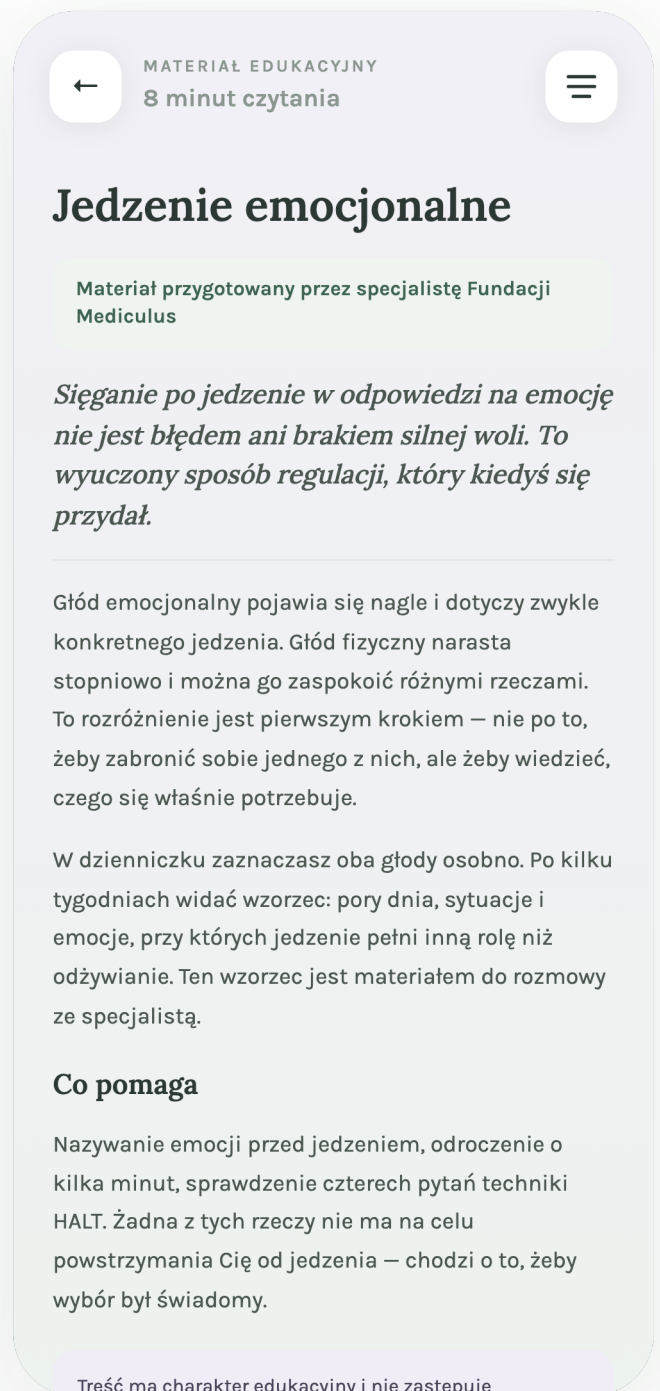
Profil jest ten sam dla obu modułów. Zmiana danych po stronie dietetycznej widoczna jest też w części psychoterapeutycznej.

UWAGA PROJEKTOWA

Pole „docelowa masa ciała” zostaje w profilu, bo specjalista go potrzebuje – ale nigdzie indziej w aplikacji się nie pojawia. Nie ma go na stronie głównej, w podsumowaniu dnia ani w raporcie.



Dwie sekcje, karty z tytułem i szacowanym czasem czytania.



Pojedynczy materiał: tytuł, podpis autorstwa, lead, tekst i stopka o charakterze edukacyjnym.

BIBLIOTEKA

Jedna biblioteka dla obu modułów

Z poziomu modułu dietetycznego widoczne są tematy dietetyczne i psychodietetyczne. Tematy psychologiczne – regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem, techniki DBT i CBT, mindfulness, motywacja, samoakceptacja, profilaktyka wypalenia – są dostępne z modułu psychoterapeutycznego.

UWAGA PROJEKTOWA

Materiały o obrazie ciała i samoocenie wymagają szczególnej redakcji – to jedyne teksty w bibliotece, które mogą trafić do osoby w czynnym epizodzie zaburzenia odżywiania. Warto rozważyć ich osobną recenzję przed publikacją.

Podział odpowiedzialności

Treść merytoryczną artykułów przygotowuje fundacja. Zespół projektowy dostarcza strukturę biblioteki, szablon materiału i widok czytania.

Autorstwo i stopka

Podpis „Materiał przygotowany przez specjalistę Fundacji Mediculus” stoi zaraz pod tytułem. Zastrzeżenie o charakterze edukacyjnym zamyka każdy artykuł.

Tylko tekst

Bez filmów i nagrań. Ewentualnie prosta grafika ilustrująca pojęcie – nigdy zdjęcia jedzenia ani sylwetek.

PALETA

Szałwia
#4F7A64

Zieleń jasna
#7FA98F

Lawenda
#F0EDF6

Ochra
#E0B45C

Grafit
#2C3833

Ochra jest kolorem części dietetycznej – nadtytuły modułu, stany aktywne, oznaczenia etapu 2. Dominanta pozostaje szalwiowo-zielona, żeby oba moduły czytały się jako jedna aplikacja.

KOLORY EMOCJI

Radość
#E8B84B

Smutek
#5B8DD1

Lęk
#8E6FCB

Złość
#D9534F

Stres
#E0874C

Poczucie winy
#2E9C8E

Frustracja
#C94E9B

Wstyd
#C98698

Bezradność
#7C8794

Spokój
#6FAE7F

Identyczne z modulem psychoterapeutycznym. Ten sam kolor oznacza tę samą emocję w obu dzienniczkach – dzięki temu dane dają się zestawiać.

TYPOGRAFIA

Lora Semibold

Nagłówki ekranów i
tytuły sekcji · 17-27 px

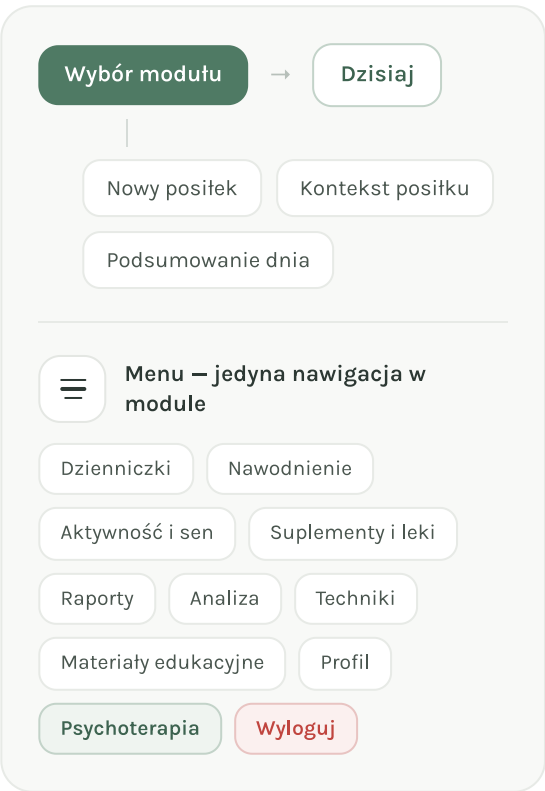
Karla Semibold

Etykiety, przyciski,
wartości liczbowe · 12-
16 px

Karla Regular

Tekst pomocniczy i
treść · minimum 10,5
px, pola dotykowe min.
44 px

PRZEPŁYW NAWIGACJI MODUŁU



KOMPONENTY

Przycisk główny

Drugorzędny

Chip aktywny

Chip

Informacja

TON KOMUNIKACJI

Mówimy na „Ty”, ciepło i bez oceniania jedzenia. Nie ma tu sformułowań „przekroczyłaś limit”, „za dużo”, „niezdrowe”, „zdrowy wybór”, „schudnij”. Aplikacja nie diagnozuje, nie zastępuje kontaktu ze specjalistą i nie jest narzędziem pomocy w kryzysie – ta informacja jest widoczna w treści ekranów, nie w stopce. Jeden ekran to jedno zadanie; nic nie wyskakuje samo i nic nie wymaga natychmiastowej odpowiedzi.

UWAGA PROJEKTOWA

Konsekwencja przyjęta w całym module: dzienniczek nie liczy jedzenia, tylko je opisuje. Nigdzie w makiecie nie pojawia się liczba kalorii ani gram makroskładnika – dotyczy to również raportów, analizy i profilu.